চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণ

খসড়া জাতীয় কর্মকৌশল ২০১৯-২০২২





২২/০৩/২০১৯

[বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদে ভিন্নতা মনে হলে, বাংলা দলিলটি মূল বলে বিবেচিত হবে]

সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ১২১২

সূচিপত্র

ভূমিকা **3**

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সিএজ) মডেলের ক্রমবিকাশ **5**

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সিজে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ **7**

.১ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সফল নেতৃত্ব 7
২. স্বাস্থ্য সেবাদানে ব্যক্তিগত ও দলগত দক্ষতা 7
৩. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা 8
৪. সরকারী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার 8
৫. জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয় 9
৬. জনসম্পৃক্ততায় হাসপাতাল সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি 9
৭. উন্নত মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম 9
৮. উন্নত শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম 10
৯. বিষয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ 10
১০. জন্ম-মৃত্যু সহ সকল স্বাস্থ্য সূচকের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রগতি মূল্যায়ন ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি 10
১১. ইউনিট ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন 10
১২. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা 11
১৩. প্রাতিষ্ঠানিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) ও সৌন্দর্যবর্ধন 11
১৪. জরুরি প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা 11
১৫. দূর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন 12
.১৬ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে "৫, এস কাইজেন-টিকিউএম" (5, S KAIZEN TOTAL QUALITY MANAGEMENT) বাস্তবায়ন .12
১৭. ক্যাশ কাউন্টার স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উন্নতি 13

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) মডেল সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা **13**

রূপকল্প (VISION) **13**

ব্রত (MISSION) **14**

লক্ষ্য (GOAL) **14**

লক্ষ্যমাত্রা (TARGET) **14**

উদ্দেশ্য (OBJECTIVES) **14**

কর্মকৌশল সমূহ (STRATEGIES) **14**

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণ কমিটিসমূহ 15
১. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি *15*
২. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি *16*
৩. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জেলা হাসপাতাল কমিউনিটি সহায়তা কমিটি *17*
৪. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জেলা সদর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি *18*
৫. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কমিউনিটি সহায়তা কমিটি *18*
৬. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বাস্তবায়ন কমিটি *19*

জাতীয় কর্মকৌশল বাস্তবায়ন সূচী **19**

প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়নসূচী **20**

উপসংহার **21**

সংযুক্তি **22**

সারনী ১. চৌগাছা মডেল বিকাশের মাইলফলক 22
সারনী ২. ঝিনাইদহ মডেলের কার্যক্রমের মাইলফলক 22
সারনী ৩. চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কার্যক্রমের অগ্রগতি (১৯৯৫-২০১৭) 23
সারনী ৪. ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল কার্যক্রমের অগ্রগতি (১৯৯৮-২০১৭) 23
সারনী ৫. খুলনা বিভাগের প্রসব সেবার ২০১১ ও ২০১৭ সালের তুলনামূলক চিত্র 24
সারণি ৬. বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য খাতে সম্পদ বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র 24
সারণি ৭. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা 25
সারণি ৮. স্বাস্থ্য **সংক্রান্ত এসডিজি লক্ষ্য**, **লক্ষ্যমাত্রা** (**১৩**), **ও নির্দেশক** (**২৭**) 26

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সিজে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ

ভূমিকা

জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, এবং সমাজ, নিজেদের ও সমাজের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণের দায়িত্ব পালন করে এবং সমাজের স্বাস্থ্য উন্নয়নে অবদান রাখতে সমর্থ হয়। জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জনগণ নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে (১) পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ণে অংশগ্রহণ (২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন, জনবল ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহে সহায়তা; এবং (৩) জনসচেতনতা তৈরি এবং স্বাস্থ্য সেবায় যুক্ত হয়ে তা ব্যবহারে সহায়তা করতে পারে।

জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের ন্যায় বাংলাদেশও আগামী ২০৩২ সালের মধ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর নাগরিকের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সকলের জন্য আর্থিক সুরক্ষাসহ মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নিরিখে চ্যালেঞ্জ হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রায় ৮০% ভাগ জনসাধারণ সরকারী হাসপাতাল হতে স্বাস্থ্যসেবা নেন না, মাত্র ২৩% প্রসব সরকারী হাসপাতালে হয়ে থাকে; উপজেলা হাসপাতালগুলো অনেকাংশেই অব্যবহৃত থেকে যাচ্ছে। এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের উপজেলা-জেলা সহ বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সম্পদের বিনিয়োগ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা প্রমিতমানে উন্নয়নসহ কাঙ্খিত স্বাস্থ্য সূচক সমূহ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। হাসপাতালে ব্যবস্থাপকদের সুযোগ্য নেতৃত্বদান; হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা; সকল স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের দলবদ্ধভাবে স্বাস্থ্য সেবায় যুক্তকরণ; জনবল, সরঞ্জামাদি, ঔষধপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য উপকরণের নিয়মিত যোগান; ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠি – বিশেষত: মা ও শিশুবান্ধব স্বাস্থ্য সেবা; স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং সেবা গ্রহণে স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রশাসনের সম্পৃক্ততা প্রভৃতি ছাড়া সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

বাংলাদেশে সফল টিকাদান কর্মসূচি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন – সরকারী কার্যক্রমের সাথে জনসম্পৃক্ততার উজ্জ্বল উদাহরণ। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার সফল মাইলফলক হল চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) মডেল। সি-জে মডেল হল উপজেলা-জেলা পর্যায়ের সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের এমন একটি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা, যা নৈতিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে জনকল্যাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ দক্ষ ব্যক্তি ও দলের নেতৃত্বে স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় সরকারী সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। এর পাশাপাশি জনগণের সহযোগিতা নিয়ে স্বল্প সময়ে সরকারী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার মাধ্যমে জনগণের চাহিদা পূরণ করে। এ মডেল আস্থাশীল সেবা ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় জনগণের অধিকারবোধ প্রতিষ্ঠিত করে। ‘চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সিজে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা’ বাংলাদেশের সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মডেল হিসাবে সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ অন্যান্য সংস্থারও আস্থা অর্জন করেছে। সিজে মডেলের বড় উপাদান হলঃ ’জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ নেতৃত্ব’, ‘জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা’ এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিষয়ে স্থানীয় ‘জনগণের অধিকার বোধ’। চৌগাছা এবং ঝিনাইদহ এবং অনুরূপ ব্যবস্থাসম্পন্ন আরও কিছু হাসপাতালে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মূল রূপকার হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদের বিশেষ কিছু গুণাবলী যেমন: নেতৃত্ব, স্বাস্থ্য সেবায় উৎসর্গীকৃত মনোভাব, কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক উপস্থিতি, ভাল ব্যবহার, স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দলবদ্ধভাবে স্বাস্থ্যসেবা, লক্ষ্য নির্ভর স্বাস্থ্য কর্মসূচী, বিরাজিত

সরকারী সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহ করে জনবল-সরঞ্জামাদির ঘাটতি মোকাবেলা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং জনপ্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক, ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে উদ্ভূত জটিল কোন সমস্যা নিরসনে স্থানীয় জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে, যা স্বাস্থ্য সেবা গতিশীল রাখতে প্রভূত ভূমিকা পালন করেছে। এ মডেলের আরো একটি উপাদান হচ্ছেঃ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে স্থানীয় জনগণ ও বিত্তবান ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় স্বাস্থ্যসেবা সহায়ক জনবলের যোগান এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী সরবরাহ করা। পাশাপাশি, সেবাদানকারী ব্যক্তিবর্গের (চিকিৎসক, সেবিকা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী) নিরাপত্তা বিধান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ জনবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে এ সব হাসপাতালে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার এ মডেলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন, স্থানীয় চিকিৎসক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, আইন শৃংখলা বাহিনী, সাংবাদিক, শিক্ষক, বেসরকারী সংস্থা, বিত্তশালী দাতা ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করছেন। এটা সবিশেষ লক্ষণীয় যে, যে সব দেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছে সে সব দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার সরাসরি স্বাস্থ্য সেবায় সম্পৃক্ত থাকে। আমাদের দেশেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। যে সব স্থানে এ মডেল পূর্ণ বা আংশিকভাবে চলমান সেখানে স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ সম্ভব হয়েছে এবং সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মান উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হয়েছে, সর্বোপরি সুশাসন ও জনপ্রশাসনের জনকল্যাণধর্মী উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে।

এ সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা গ্রহণের পরিমাণ এবং মান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শয্যা ব্যবহারের হার ১৯৯৭ সালে ৭৮.৯% হতে ২০১১ সালে ২০৮.০%এ উন্নীত হয়; গর্ভকালীন পরিচর্যা ১৯৯৬ সালে ৮১৭ (১৬.৩%) হতে ২০১১ সালে প্রথম ভিজিট ৮৯৩৫ (১৭০%)এ উন্নীত হয়; হাসপাতালে প্রসব ১৯৯৬ সালে ৯৯ (২.১) হতে ২০১১ সালে ৪৪১৩(৯৮.৪%) এ উন্নীত হয়; প্রয়োজনীয় সিজারিয়ান সংখ্যা ১৯৯৬ সালে ১ (.০২%) হতে ২০১১ সালে ১০০৭ (২২.৫%) এ উন্নীত হয়। সিজে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা চৌগাছা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সূচকেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে: ১৯৯৫ সালে মাতৃমৃত্যু হার ১ লক্ষ জীবিত জন্মে ৫৯৯ হতে ২০১১ সালে ৬৮ তে নামিয়ে এনেছে, নবজাতক এবং অনুর্ধ ৫ বছরের শিশু মৃত্যু ১৯৯৫ সালে যথাক্রমে ৪২ ও ৭৮ হতে ২০১১ সালে ১৮.২ ও ২৩.৬ এ নেমেছে। ২০১৭ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, নানা কারণে এ অগ্রগতি কিছুটা শ্লথ হলেও এখনও তা অন্যান্য উপজেলাগুলোর চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে শ্রেয়তর।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালেও সিজে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহণকারী রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে; ১৯৯৮ সালে বহিঃবিভাগ ও জরুরী বিভাগে রোগীর সংখ্যা ৮১,৭৯৫ জন হতে ২০১৭ সালে ৩৪০,৯৩২ জন এবং অন্ত:বিভাগে তা ১২, ৯৭৩ হতে বেড়ে ২০১৭ সালে ৩৫, ৫৬৯ জনে পৌঁছায়। শয্যায় অবস্থানের হার ১২৬% হতে ২৪২% এবং প্রসবের সংখ্যা ১,১০৬ হতে ২,৯৯৭এ পৌঁছায়। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালের মধ্যে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল প্রসব সেবায় যথাক্রমে ২০১১ এবং ২০১৭ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে।

উপরোক্ত দুই হাসপাতাল এবং দেশের আরও কিছু সংখ্যক হাসপাতাল অনুরূপ ব্যবস্থাপনায় সরকার হতে অতিরিক্ত কোন বরাদ্দ ছাড়াই সেবার পরিমাণ, গুণগতমান এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়েছে। দেশে

সরকারী হাসপাতালগুলোর সেবার পরিধি ও মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল অনুকরণীয় হতে পারে। এ উদাহরণকে সামনে রেখে সরকার তাই সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেশের সকল সরকারী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট মানদন্ডের ভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করে পর্যায়ক্রমে সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সিএজ) মডেলের ক্রমবিকাশ

চৌগাছা-ঝিনাইদহ জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল এর প্রাথমিক সূচনা ১৯৮৫ সালে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায়। তৎকালীন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা ডা. হুমায়ুন মোল্লা[২] এর নেতৃত্বে একদল তরুণ চিকিৎসকের হাত ধরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে বহিঃবিভাগ ও মাঠ পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবার ব্যপ্তি ঘটে, তরুণদের অন্যতম একজন ছিলেন ডা. মো. ইমদাদুল হক।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা স্বত্ত্বেও সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রয়োগ করে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে তারা স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জকে সফলভাবে মোকাবেলা করেন। ১৯৮৬ সালে উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় একটি টালির ঘরে থাকা অপরিসর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি নিকটস্থ পাবলিক লাইব্রেরিতে সম্প্রসারিত হয়, খোলা হয় অন্তঃবিভাগ, তৈরি হয় ইপিআই ভবন। স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় ক্লাব-সমিতি ও জনগণের সহযোগিতায় চক্ষু ক্যাম্পসহ নানা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। ফলে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি ইপিআই কাজের সফলতায় জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় সরকার তথা স্থানীয় জনগণকে সফলভাবে সম্পৃক্ত করেন এ চিকিৎসক দলটি। স্বাস্থ্যসেবায় বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহিষ্ণুতা ছিল এ নতুন ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনগণের আস্থা অর্জনে এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

ডা: ইমদাদুল হকের নেতৃতে নড়াইল জেলার লোহাগড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চৌগাছার জনসম্পৃক্ততার দৃষ্টান্ত আরো বিস্তৃত হয় ১৯৮৯-৯৫ সালে। তিনি উদ্যোগী হয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবাসহ সার্বিক উন্নয়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জনপ্রশাসন কর্মকর্তা, শিক্ষক, সমাজকর্মী এবং লোহাগড়ায় জন্মগ্রহণকারী উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেন।[৩]

চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৬-শয্যা থেকে ৩১-শয্যায় উন্নীত হয়ে ১৯৯৪ সালে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। সে সময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আব্দুল মান্নান। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে তিনি নতুন ভবনে ৬ শয্যা বিশিষ্ট প্রসূতি ওয়ার্ড চালু করেন। ১৯৯৫ সালে ডাঃ ইমদাদুল হক পুনরায় চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বদলি হয়ে আসেন। তার সাথে ছিল লোহগড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা। ঐ সময়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা, ওআরটি কর্ণার, ইপিআই কর্ণার, ও জন্ম মৃত্যুর তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালু হয় – যা ছিল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সচরাচর কার্যক্রমের বাইরে। ১৯৯৫-১৯৯৮ সালে জাইকার (জাপান) ফ্রন্টলাইন এমসিএইচ প্রোগ্রামের অধীনে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়।

১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে ডাঃ এএসএম আব্দুর রাজ্জাক ও ডাঃ সেলিনা খাতুন চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগদান করেন। তাদের সহযোগিতায় মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের চাহিদা মেটাতে গিয়ে স্থানীয় উদ্যোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ গর্ভবতী মায়েদের জন্য গর্ভকালীন সেবার উদ্দেশ্যে এন্টেনেটাল কর্নার ও অনুর্ধ ৫ বছরের শিশুদের জন্য আন্ডার ফাইভ কর্নার, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৯৭ সালের জানুয়ারিতে বেজ লাইন জরিপ

করে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এ সময়ে জনপ্রশাসন, দানশীল ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় জনগণের সহযোগীতায় সেনিটেশন উন্নয়ন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে বিশেষ কার্যক্রম চালু করা হয়।[৪] প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ৮টি উপাদানের সফল বাস্তবায়নে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ছিল সবার শীর্ষে। জনবান্ধব সৃজনশীলতা ও জনসম্পৃক্ততা ছিল এ সাফল্যের চাবিকাঠি। ১৯৯৮ সালে চৌগাছার ৮ জন নার্সকে ফ্রন্টলাইন এমসিএইচ কর্মসূচীর আওতায় যশোরের আদ-দ্বীন হাসপাতাল থেকে প্রসূতি সেবার উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সে সময় প্রসূতি সেবাতে নার্সদের এখনকার মত দক্ষতা ছিল না। ২০০০ সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রমের অধীনে চৌগাছাতে 'কম্প্রেহেন্সিভ ইওসি' কার্যক্রম শুরু হয়। কমিউনিটি সহযোগীতায় জনবল সংগ্রহ করে ২০০৬ সালে নতুন প্রসূতি ভবন চালু করা হয়। এভাবেই জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার মডেলটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়।

স্থানীয়ভাবে ২০০১ সালে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ২০১০ সাল নাগাদ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটি ভিশন-২০১০ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়, যা ছিল উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যতিক্রম। চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ২০০৮ সালে ৩১-শয্যা হতে ৫০ শয্যায় উন্নীত হয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মডেল হিসেবে ঘোষণা করে। এ ঘোষণার ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক ডা. মার্গারেট চ্যান চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবং মডেলটিকে সারা দেশে সম্প্রসারণের বিষয়ে সুপারিশ করেন।[৫]

উপজেলাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ১ জানুয়ারি ২০১১ সালে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু হয়, যার মূলে ছিল স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সৃজনশীল উদ্যোগ।[৬] মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপের কারণে ২০১১ সালে ডিসেম্বর মাসে চৌগাছার প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারির হার ৯০% এর ঊর্ধে ওঠে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে উদাহরণ সৃষ্টি করার স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৭ সালের মে মাসে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিকে ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করার কার্যক্রম শুরু করে।

ডাঃ মো. ইমদাদুল হক ২০১২ সালের মে মাসে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে সিনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনি) হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালে হাসপাতালটি ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত হলেও দীর্ঘ ১৮ বছরে জনবলের পদ তৈরি হয়নি। কিন্তু হাসপাতালে রোগী বেড়েছে ৩ গুণ। তখন হাসপাতালটিতে আয়া, ওয়ার্ড বয়, গার্ড, গার্ডেনার, ট্রলিম্যান, ইলেক্ট্রিশিয়ানের কোন পদ ছিল না। সরকারি ক্লিনারের প্রয়োজন ছিল ৩৬ জন, কিন্তু ছিল মাত্র ৬ জন। ফলে হাসপাতালটি তখন জনবলের অপ্রতুলতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব, নিরাপত্তাহীনতা ও অব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ সমস্যায় ভুগছিল। ঐ সময়ে সাভার লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে সেবার মানোন্নয়নে ৫'এস কাইজেন পদ্ধতির প্রশিক্ষণ চলমান ছিল। ডা. ইমদাদের উদ্যোগে ঝিনাইদহে জনসম্পৃক্ততা গড়ে ওঠে ও চৌগাছা মডেলের আলোকে সার্বিকভাবে হাসপাতালটির পরিবেশের এবং চিকিৎসা মানের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটে। ২০১৪ সালে জাইকার "নিরাপদ মাতৃত্ব উন্নয়ন'' কার্যক্রমের অধীনে প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক মানোন্নয়ন কার্যক্রম চালু হয়। ফলশ্রুতিতে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানটি দেশের জেলা হাসপাতাল গুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানসম্পন্ন জেলা হাসপাতালের স্বীকৃতি লাভ করে। ২০১৫ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ঝিনাইদহ হাসপাতালকে জেলা পর্যায়ের মডেল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করে এবং মডেলটির সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করে। ২০১৬ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চৌগাছা-

ঝিনাইদহ (সি-জে) মডেলের আলোকে ১০টি জেলা হাসপাতালে এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে এবং বর্তমানে মোট ১১টি জেলা হাসপাতাল ও ৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ মডেল বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সিজে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সফল নেতৃত্ব
২. স্বাস্থ্য সেবাদানে ব্যক্তিগত ও দলগত দক্ষতা
৩. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা
৪. সরকারী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার
৫. জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয়
৬. জনসম্পৃক্ততায় সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি
৭. উন্নত মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম
৮. উন্নত শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম
৯. বিষয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ
১০. জন্ম-মৃত্যু সহ সকল স্বাস্থ্য সূচকের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রগতি মূল্যায়ন ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি
১১. ইউনিট ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন
১২. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা
১৩. প্রাতিষ্ঠানিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) ও সৌন্দর্যবর্ধন
১৪. জরুরি প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা
১৫. দূর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন
১৬. স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে “৫এস কাইজেন-টিকিউএম” বাস্তবায়ন
১৭. ক্যাশ কাউন্টার স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থপনার উন্নতি

১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় সফল নেতৃত্ব

চৌগাছা ঝিনাইদহ মডেল সৃষ্টিতে নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সততা, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের সফল প্রয়োগে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। কখনো একক, কখনো বা যৌথ নেতৃত্বও এ মডেলে ভূমিকা রেখেছে। এ মডেলের সাফল্য নির্ভর করে দক্ষ দলের মধ্য হতে কারো না কারো উদ্যোগী ভূমিকা। ব্যক্তিবিশেষের উদ্যোগী ভূমিকা এ মডেল বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

২. স্বাস্থ্য সেবাদানে ব্যক্তিগত ও দলগত দক্ষতা

স্বাস্থ্যসেবাদান একটি দলগত প্রচেষ্টার সফল মঞ্চায়ন; ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, নার্সসহ সকল ধরণের কর্মীর ব্যক্তিগত এবং দলগত দক্ষতা এবং কার্য সম্পাদন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একজন সফল নেতা দল গঠন, পরিচালনা এবং কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে দলকে উজ্জীবিত করেন। ঝিনাইদহ ও চৌগাছা উভয় স্থানেই স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের সক্রিয় ভূমিকা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এ মডেল সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে।

তাদের উদ্যোগকে উৎসাহ যুগিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারীগণ। এছাড়াও রয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অব্যাহত সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান।

৩. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা

স্বাস্থ্য জনগণের সম্পদ। স্বাস্থ্যবান থাকা জন অধিকার। সে সম্পদের উন্নয়ন ও রক্ষায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হওয়া উচিৎ। নিজেদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিরূপন, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রয়োজনে সম্পদের যোগানের মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ চালু রাখা জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে সম্ভব। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ২০১৭ সালে কমিউনিটি সহযোগিতায় চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩১ জন ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ৫৬ জন সহযোগী জনবল পাওয়া যায়। সরকারী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার পরেও সম্পদের অপ্রতুলতা থেকে যায়। সেটা পূরণে জনসম্পৃক্ততা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। চৌগাছা, ঝিনাইদহ ও অনুরূপ অন্যান্য উপজেলা- জেলা স্বাস্থ্য স্থাপনায় এর সাফল্য দেখা গেছে – যা উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এমনকি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবহার বৃদ্ধিতেও জনসম্পৃক্ততা প্রভাব রাখে। জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় জনগণ নিজস্ব স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে (১) পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ণে অংশগ্রহণ (২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন, জনবল ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহে সহায়তা; এবং (৩) জনসচেতনতা তৈরি এবং স্বাস্থ্য সেবায় যুক্ত হয়ে তা ব্যবহারে সহায়তা করতে পারে। জনসম্পৃক্ততার ফলে চৌগাছা ঝিনাইদহ মডেলে শয্যা ব্যবহারের হার বেড়েছে, সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থায় আস্থা বাড়ার কারণে গ্রামীণ এলাকায় সরকারী হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি মৃত্যুহার হ্রাস সহ নানা স্বাস্থ্য সূচকে তার প্রভাব পড়েছে। জনসম্পৃক্ততায় স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং নাগরিক সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগ ছাড়া অন্যান্য সরকারী দপ্তরসমূহের সহযোগ্যীতা ও সমন্বয় এ মডেলের সফলতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, চৌগাছা উপজেলাতে নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে অফিসার্স ক্লাব আছে। এই অফিসার্স ক্লাবে চিকিৎসক সহ সকল কর্মকর্তা ও স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক বৃন্দ সংশ্লিষ্ট আছেন। ফলে এসমস্ত ব্যাক্তিবর্গের সরকারি কাজ ও সামাজিক উন্নয়নে একযোগে ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। চৌগাছাতেও অফিসার্স ক্লাব চক্ষু শিবির, ছাত্রদের জন্য বৃত্তি ফাউন্ডেশন, পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, জন্ম-মৃত্যু তথ্য সংগ্রহ ও নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। ফলে সরকারি বিভন্নি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে।

আফিসার্স ক্লাবের ন্যায় প্রেস ক্লাবের সাথেও চিকিৎসকদের একটি সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে তারা এলাকায় হাসপাতালের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। চৌগাছা ও ঝিনাইদহ উভয় স্থানে সাংবাদিকবৃন্দ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের আন্তরিকতা পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

৪. সরকারী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার

সরকারী সম্পদের মধ্যে রয়েছেঃ জনবল, অর্থ, স্থাপনা, কর্মসময় সহ অন্যান্য সম্পদ। সততা ও দায়িত্বশীলতার সাথে এ সমস্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এ মডেলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই জনগণ সম্পদের ঘাটতি পূরণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে।

৫. জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থাসমূহের সাথে কার্যকর সমন্বয়

স্থানীয় জনপ্রশাসন স্থানীয় ভাবে বাস্তবায়িত যে কোন কর্মসূচীতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাগণ উপজেলার জন্য স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। যে সমস্ত উপজেলায় পৌরসভা আছে, সেখানে অনুরূপ ভাবে পৌরসভাও পৌরবাসীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। সম্পদের সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ, তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ, প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা মহামারী মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষাদান ইত্যাদি নানা কর্মকান্ডে তাদের সংশ্লিষ্টতা অপরিহার্য। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে জনপ্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা সমাজকল্যাণসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহের ভিতরে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সি জে মডেল এর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে জনপ্রশাসনসহ অন্যান্য সরকারী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।

৬. জনসম্পৃক্ততায় হাসপাতাল সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি

সাম্প্রতিক কালে হাসপাতালে নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে দাঁড়িয়েছে। রোগী বা তাদের আত্মীয়স্বজনের নানা ধরণের অসন্তুষ্টির বহি:প্রকাশ ঘটছে সেবাদানকারী বা হাসপাতালের উপর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হামলায়। আমাদের উপজেলা এমনিক জেলা হাসপাতালেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অনুপস্থিতিতে সেবাদানকারীদের মধ্যে প্রায়শই নিরাপত্তাহীনতাবোধ কাজ করছে। চৌগাছা-ঝিনাইদহে সর্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে এ আদর্শ ব্যবস্থাপনাতে। নিরাপত্তায় স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগানো এর গুরুত্বপূর্ণ দিক। কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠনসহ জনসম্পৃক্ততার নীতির কারণে চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্কতে এক নতুন আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। তুচ্ছ কারণে হাসাপাতাল, চিকিৎসক বা রোগীদের ওপর হামলা বন্ধ হয়েছে। পরস্পরের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

৭. উন্নত মাতৃ স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

সকল গর্ভবতী মায়ের কমপক্ষে ৫ বার গর্ভকালীন সেবা সরাসরি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকের নিকট থেকে নেয়া এবং শত ভাগ মাকে হাসপাতালে ডেলিভারী করানো ছিল চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অন্যতম মূল মন্ত্র। বারবার হাসপাতালে আসার ফলে প্রসূতি মায়েদের সাথে সেবাদানকরীদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে ও হাসপাতালের কার্যক্রম সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ ধারণা ও আস্থা সৃষ্টি হয়। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারিতে গর্ভবতী মায়েরা উৎসাহী ও সাহসী হয়ে ওঠে। সেখানে জরুরী ধাত্রী সেবা (ইওসি) অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে প্রদান করায় স্বাভাবিক প্রসবের হার বেড়েছে ও সিজারিয়ন সেকশনের হার কমেছে। ফলে মাতৃমৃত্যুর হার ও নবজাতক মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। উন্নত মাতৃসেবার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নিরাপদ রক্ত সরবরাহ। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণকে রক্তদানে উৎসাহিত করে এবং জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে রক্ত সংগ্রহ ও রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যাবস্থা করেছে। প্রসূতি মায়েদের জরুরী স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজনে হাসপাতালে সর্বক্ষণিক (২৪/৭) জরুরী অপারেশন সেবা চালু আছে। কাজগুলোকে সহজ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক (নার্স সহযোগী) ব্যবস্থা চালু করে জনবল সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। প্রসূতি মায়েদের জন্য অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রসূতি ওয়ার্ডটিকে দুর্গন্ধমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করার নিমিত্তে জুতামুক্ত পরিবেশ, গোপনীয়তা রক্ষার ও আস্থা সৃষ্টির জন্য ওয়ার্ডকে নারী বান্ধব করা হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিপদে অর্থ সঞ্চয়ের নিমিত্তে গর্ভবতী হবার শুরুতেই মাটির ব্যাংক প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়।

৮. উন্নত শিশু স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

স্থানীয় উদ্যোগে ১৯৯৬ সাল থেকে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনুর্দ্ধ ৫ বছরের শিশুদের জন্য আন্ডার ফাইভ কর্নার কার্যক্রম শুরু করা হয়, যা সরকারিভাবে আইএমসিই কর্নারের নামে চালু হয় ২০০৭ সালে । আন্ডার ফাইভ কর্নারে, শিশুদের পুষ্টিমান পরিমাপের জন্য গ্রোথ চার্ট ব্যবহার করা হয়। শিশুদের ইপিআই টিকা, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়ার চিকিৎসা সহ প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এখান থেকে সকল শিশুকে রেফার করে একজন নির্ধারিত চিকিৎসকের কাছে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য যে, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির অন্তঃবিভাগে ১৯৯৬ সাল থেকে পৃথক শিশু ওয়ার্ড খোলা হয়। এ কার্যক্রম চৌগাছাতে ধারাবাহিকভাবে চলার ফলে শিশু মৃত্যুহার ও অপুষ্টির হার কমেছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বাড়ার কারণে নবজাতক মৃত্যু হার কমেছে।

৯. বিষয়ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ

মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করে বিষয়ের ভিত্তিতে সেবা দেয়া হয়েছে। এ মডেলের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে লিঙ্গ, বয়স ও স্বাস্থ্য সমস্যার প্রকার ভেদে পুরুষ, নারী, কৈশোর স্বাস্থ্য, আইএমসিআই, এএনসি, পিএনসি, ভায়া, ইপিআই, ব্রেস্ট ফিডিং, ওআরটি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, এনসিডি ইত্যাদি বিষয়ে কর্নার তৈরী করে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হচ্ছে। উপজেলা পর্যায়ে অন্তঃবিভাগকে চারটি ভাগে ভাগ করে পুরুষ, নারী, শিশু এবং প্রসূতি বিভাগে পৃথক করা হয়েছে। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে জরুরী স্বাস্থ্য সেবায় ২৪/৪ ভিত্তিতে সার্বক্ষণিকভাবে চিকিৎসক বা মেডিক্যাল এসিস্টেন্ট দায়িত্ব পালন করছেন। এতে বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্বশীলদের দায়বদ্ধতায় আনা গেছে। বহির্বিভাগে কর্নারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কারণে রোগীদের অপেক্ষার সময় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে, সর্বোপরি রোগীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যসেবায় উন্নতি হয়েছে। এতে বহির্বিভাগে যেমন রোগীর সংখ্যা ও সন্তুষ্টি বেড়েছে, অন্যদিকে অন্তর্বিভাগে বিশেষজ্ঞদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কারণে বড় অপারেশনের সংখ্যা বাড়ায় শয্যা ব্যবহারের হারও বেড়েছে অনেকগুণ।

১০. জন্ম-মৃত্যু সহ সকল স্বাস্থ্য সূচকের তথ্য সংগ্রহপূর্বক অগ্রগতি মূল্যায়ন ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টি

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জন্ম-মৃত্যু তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভাগ দুটিতে জন্ম তথ্য সঠিক ভাবে সংগ্রহ করা হলেও মৃত্যু তথ্য সংগ্রহে দুর্বলতা দেখা যায়। ফলে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, নবজাতক মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার, মাতৃমৃত্যুহার সহ বয়স ও রোগ ভিত্তিক সঠিক মৃত্যু তথ্য জানা সম্ভব হয় না। ফলে কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এমনকি দায়বদ্ধতাও সৃষ্টি করা যায়নি। চৌগাছা উপজেলায় ১৯৯৫ সাল থেকে প্রাথমিক ভাবে এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে দীর্ঘ ২২ বছর চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। জন্ম-মৃত্যুর তথ্য ছাড়াও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যান্য কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন ও প্রচারের ক্ষেত্রে চৌগাছা ও ঝিনাইদহ হাসপাতাল অনন্য ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন সহজতর হয়েছে।

১১. ইউনিট ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন

এ আদর্শের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবাসমূহকে যান্ত্রিকভাবে খন্ড খন্ড বিবেচনা না করে রোগীর প্রয়োজন বিবেচনা করে তার সামগ্রিক সেবা নিশ্চিত করা। এ ব্যবস্থাপনায় সেবাদানকারী তার নিজের পেশাগত খন্ড কাজ

সম্পন্ন করেই তার দায়িত্ব শেষ এটা মনে করেন না। তিনি পরবর্তী ধাপে রোগী প্রয়োজনীয় সেবা পাচ্ছেন কি না তা অনুসরণ করেন। ওয়ার্ডের প্রধান তার রোগীদের ভর্তি হওয়া থেকে হাসপাতাল ছাড়া পর্যন্ত সেবা ব্যবস্থাপনার সকল দিককে বিবেচনায় রাখেন। তার ইউনিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সময়মত উপস্থিতি, ইউনিটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রোগীদের খাদ্য সরবরাহ, ওয়ার্ডের অনাবশ্যক ভীড় নিয়ন্ত্রণসহ সকল বিষয়কে বিবেচনায় আনেন। ঝিনাইদহ হাসপাতালে এ বিষয়টিকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবাদানকারী একই সাথে স্তরভেদে তার বিশেষায়িত কাজের পাশাপাশি ব্যবস্থাপনার দিকটিকেও সৃজনশীল ও মানবিকভাবে দেখেছেন।

১২. স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরি করা

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ। রোগীদের আচরণ পরিবর্তন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন জাতীয় কার্যক্রম (যেমনঃ প্রসূতি সেবা, শিশু স্বাস্থ্য সেবা, কৈশোর স্বাস্থ্য সেবা, সংক্রামক রোগ, অসংক্রামক রোগ, পরিবার পরিকল্পনা, ইপিআই, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, জলাতংক প্রভৃতি) এবং অন্যান্য সরকারী সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে জানানো এবং সরকারী সেবা নিতে উৎসাহিত করা এ স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল লক্ষ্য। দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ সময়ে সময়ে উপস্থিত থেকে রোগীদের সমস্যা ও সুপারিশসমূহ অবহিত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে তিনটি এবং চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ধরণের দু'টি স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্নার চালু আছে। প্রতি দিনেই এ কার্যক্রম অডিও ভিসুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্নারে রোগীদের বসার স্থান এবং অন্যান্য সুবিধা রাখা হয়েছে। জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন বীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী ও স্বজনদের জন্য লাইব্রেরি চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষায় প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ব্যক্তি থেকে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক সাপ্তাহিক রোস্টারের মাধ্যমে এবং দায়িত্ব বন্টন করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

১৩. প্রাতিষ্ঠানিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) ও সৌন্দর্যবর্ধন

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা একদিকে হাসপাতালে রোগ সংক্রমণের আশংকা থেকে দূরে রাখে, অন্য দিকে দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশে রোগীদের সংবেদনশীল মন উৎফুল্ল রাখতে সহায়তা করে। পরিচ্ছন্নতা শুধু হাসপাতালেই নয়, বহিরাঙ্গনসহ গোটা এলাকাকেই পরিচ্ছন্ন রাখা অপরিহার্য। প্রাঙ্গনে আকর্ষণীয় ফুলের বাগান, ভেষজ বাগান, পুষ্টি বাগান তৈরী ও তা নিয়মিত পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয় জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্বলিত হাসপাতালে। সরকারী জনবল অপ্রতুল হওয়াতে জনগণের আর্থিক সহায়তায় পরিচ্ছন্নতার কাজে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করাতে পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধ মুক্ত হয়েছে। চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যসেবাদানকারীগণ আনুষ্ঠানিকভাবে কোন জাতীয় দিবসে একসাথে নিজেরাই গোটা হাসপাতাল ও প্রাঙ্গনে ঝাড়ু হাতে পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশ নেন। এটিকে "বিগ ক্লিনিং ডে" বলা হয়।

১৪. জরুরি প্রয়োজনে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের ব্যবস্থা

নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন স্বাস্থ্য সেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যে কোন বড় অস্ত্রোপচার বিশেষ করে সিজার অপারেশনের সময় ও প্রসূতি মায়েদের প্রসবকালে নিরাপদ রক্তের জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়ে। চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৯৯৬ সালের বিজয় দিবসে রক্তদাতা সংগ্রহের লক্ষ্যে রক্ত গ্রুপিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। সে সকল ব্যক্তিদের রক্ত গ্রুপিং করে তালিকাবদ্ধ করা হয়, যাদের বাড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে। প্রায় ৬০০ জন রক্ত দাতার নাম তালিকাবদ্ধ করা হয়। এ সকল রক্ত দাতাকে "চলন্ত রক্ত ব্যাংক" হিসেবে অভিহিত করা

হয়। তখন থেকে চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগীদের জন্য কখনও রক্তের অভাব ঘটেনি। ফলে, জরুরি প্রসূতি সেবায় রক্তের অভাবে মাতৃমৃত্যু কমে যায়। রক্তদাতা সংগ্রহের জন্য প্রতিটি জাতীয় দিবসে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। দূর্গা পুজা মন্ডপেও এ উদ্যোগ নেওয়ায় সফলতা দেখা গেছে। রক্ত দাতাদের কাছ থেকে গভীর রাত্রে রক্ত সংগ্রহের জন্য আরেকটি দায়িত্বশীল গ্রুপ তৈরি করা হয়। ২০০৫ সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালনের নিমিত্তে ব্লাড ব্যাংক চালু করা হয়।

১৫. দূর্নীতি প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতা প্রদর্শন

হাসপাতালের সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অনিয়ম ও দুর্নীতি। এ ধরণের সমস্যা মোকাবেলায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে তথা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপকদেরকে জনগণ সহায়তা প্রদান করছেন। কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপের ভূমিকার কারণে স্বাস্থ্যসেবায় প্রভাবশালীদের কারো কারো অবৈধ চাপ মোকাবেলা করা সহজ হয়েছে। এক শ্রেণির দুর্নীতিবাজদের মোকাবেলা করা, 'সন্তুষ্টি'র নামে রোগীদের কাছ থেকে অন্যায় উৎকোচ বন্ধ করাও সহজ হয়েছে। সহায়তাকারী নামে এক শ্রেণীর বহিরাগতদের জিম্মী দশা থেকে রোগীদেরকে তথা প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেয়া নিয়ে নিয়মবহির্ভূত চাপ মোকাবেলা, রোগীদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য 'দালাল' দের দৌরাত্ম্য মোকাবেলা সফলভাবে করা গেছে।

সরকারী হাসপাতালে বিশেষ করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে রোগ নির্নয়ের জন্য প্যাথলজি, এক্স-রে, ইসিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত মুল্যে ফি নেওয়ার নিয়ম চালু আছে। কিন্তু সেখানে ক্যাশ কাউন্টার না থাকায় আর্থিক অনিয়মের সুযোগ থাকে। এর সাথে প্রায়শঃই সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও দালাল জড়িয়ে পড়ে। ঝিনাইদহে এই ক্যাশ কাউন্টার স্থানীয় উদ্যোগে চালু করা হয়েছে। ফলে দেখা যায় ২০১১ সালে ঝিনাইদহ হাসপাতালে বাৎসরিক আয় ৩৪ লক্ষ টাকা। ২০১৭ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৭২ লক্ষ টাকায় উন্নিত হয়। ফলে, আর্থিক শৃঙ্খলা বেড়েছে।

১৬. স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে "৫, এস কাইজেন-টিকিউএম" (5, S Kaizen Total Quality Management) বাস্তবায়ন

হাসপাতালে মানসম্পন্ন সেবার ১ম ৫টি ধাপ হলো ৫S।
১ম Sort -অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কর্মস্থল থেকে সরিয়ে ফেলা
২য় Set - প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যথাযথভাবে সাজিয়ে রাখা
৩য় Shine -পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা
৪র্থ Standardize- উপরের তিনটি কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করা
৫ম Sustain- উল্লেখিত কার্যক্রম সমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা
Kaizen - জাপানি শব্দ কাইজেন এর অর্থ Change for better বা সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি। সার্বিকভাবে ৫S কাইজেন পদ্ধতি ব্যবহার করে মানসম্পন্ন সেবাদান সম্ভব। জাপনি সংস্থা জাইকার উদ্যোগে ২০০৯ সালে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবার গুণগত মান উন্নয়নে এই কার্যক্রম নরসিংন্দি জেলা ও সাতক্ষীরা জেলার স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান সমুহে পাইলটিং করা হয়। এর মাধ্যমে সরকারি সম্পদের কার্যকর ব্যাবহার করে হাসপাতালের পরিবেশ উন্নয়ন ও গুনগত মান উন্নয়ন হয়। চৌগাছা উপজেলা হাসপাতালে এ কার্যক্রম ২০১১ সালে শুরু করা হয়। ঝিনাইদহ

সদর হাসপাতালে, ২০১২ সাল থেকে কার্যকর ভাবে শুরু হয়। ফলে সেবাদানকারীদের কার্যক্রমের পরিবেশ উন্নত হতে থাকে। ২০১৩ সালে এর সফলতার জন্য হাসপাতালটি পুরস্কৃত হয়।

১৭. ক্যাশ কাউন্টার স্থাপনের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় উন্নতি

দেশের জেলা এবং উপজেলা হাসপাতালে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করতে হয়, এটি সরকারের রাজস্ব আদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জনবল অপ্রতুলতার কারণে মেডিক্যাল টেকটনোলজিস্টগণ একই সঙ্গে ফি ও নমুনা সংগ্রহ করেন, আবার রোগীদের নমুনা ল্যাবরেটরি/এক্স-রে প্রভৃতি রোগ নির্ণয়ের দায়িত্ব পালন করেন, রোগীদের পরীক্ষার রিপোর্ট সরবরাহ করেন। এ ধরণের ব্যবস্থার কারণে আর্থিক বিশৃংখলা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ সমস্যা উত্তরণে পৃথক ক্যাশ কাউন্টার স্থাপন করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে রোগীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় ও রশিদ প্রদান করে এ অব্যবস্থা দূর করা হয়েছে।

উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির কারণে হাসপাতালে আসা রোগীর সংখ্যা বেড়েছে আগের চাইতে অনেকগুণ। আর ডিজিটাল প্রযুক্তি ও শৃংখলা নিশ্চিত হওয়াতে উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের উল্লেখ্যযোগ্য উন্নতি ঘটেছে এ প্রতিষ্ঠানে। অন্যদিকে অনৈতিক সুযোগ বন্ধ হওয়ায় রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) মডেল সম্প্রসারণের যৌক্তিকতা

বাংলাদেশ সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফলতার পর ২০৩২ সাল নাগাদ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যক্রম তথা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে অগ্রসর হচ্ছে। এ বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়ন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়, রয়েছে নানারকম সীমাবদ্ধতা।[৭] এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাই সরকারের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্বলিত চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) মডেল ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য সেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিগত ২২ বছর যাবৎ যশোরের চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং গত ৬ বছর যাবৎ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল সহ আরও প্রায় ১৫ টি স্থানে সফলতার সাথে এ মডেলের কার্যক্রম চলছে।

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতিসহ বাংলাদেশে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' তথা সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জন করতে হলে, দেশব্যাপী উপজেলা-জেলা পর্যায়ে চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল-এর সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন হবে প্রমাণ নির্ভর, সময়োপযোগী এবং যুক্তিযুক্ত উদ্যোগ। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের সুপারিশ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আলোকে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে মডেলের সফল বাস্তবায়ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সি-জে মডেল সারাদেশে বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশে স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা

ব্রত (Mission)

২০৩২ সাল নাগাদ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা

লক্ষ্য (Goal)

বাংলাদেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতালে ২০২২ সাল নাগাদ স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে সি-জে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেলের সম্প্রসারণ

লক্ষ্যমাত্রা (Target)

জুন ২০২০ সাল নাগাদ – ২৭ উপজেলা ও ১৮ জেলা;
জুন ২০২১ সাল নাগাদ – আরো ২৫০ উপজেলা ও ৩৫ জেলা;
জুন ২০২২ সাল নাগাদ – অবশিষ্ট সকল উপজেলা ও জেলা।

উদ্দেশ্য (Objectives)

১. বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্বাস্থ্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সবর্জনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ
২. সরকারি পর্যায়ে বরাদ্দকৃত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
৩. স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও বহুমুখী অবদানের সুযোগ সৃষ্টি
৪. নেতৃত্বগুণের বিকাশ ও উদ্বুদ্ধকরণ
৫. বিষয়ভিত্তিক সেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন
৬. নানাবিধ কমিটি গঠনের মাধ্যমে দলগত কর্মকৌশলে স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও পর্যবেক্ষণ
৭. নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন এর মাধ্যমে ধারাবাহিক সফলতা, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

কর্মকৌশল সমূহ (Strategies)

১. বাংলাদেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতালে পর্যায়ভিত্তিক চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণে দেশব্যাপী প্রাথমিক জরীপ
২. জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নীরিখে উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোকে সনাক্তকরন এবং পর্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন
৩. এ মডেল সম্প্রসারণে জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি কর্মমূলককরণ
৪. দেশব্যাপী চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণে প্রচার প্রচারণা ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
৫. নির্বাচিত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পপ কর্মকর্তা এবং জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কদের নেতৃত্ব বিকাশ এবং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণদান
৬. নির্বাচিত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পপ কর্মকর্তা এবং জেলা হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল পদায়ন

৭. নির্বাচিত উপজেলা স্বাস্থ্য ও পপ কর্মকর্তা এবং জেলা হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ
৮. সরকারি পর্যায়ে বরাদ্দকৃত সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও ঘাটতি সনাক্তকরণ
৯. স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও বহুমুখী অবদানের সুযোগ সৃষ্টি
১০. দলগত কর্মকৌশলে জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি কর্মমূলককরণ
১১. স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিচালন এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ধারাবাহিক সফলতা, উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখা

চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণ কমিটিসমূহ

১. চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি
২. চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল সম্প্রসারণ টেকনিক্যাল কমিটি
৩. চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল জেলা হাসপাতাল কমিউনিটি সহায়তা কমিটি
৪. চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল জেলা হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি
৫. চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কমিউনিটি সহায়তা কমিটি
৬. চৌগাছা-ঝিনাইদহ (সি-জে) জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বাস্তবায়ন কমিটি

১. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	চেয়ারপারসন
২.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব
৩.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট, কার্যক্রম ও মুল্যায়ন), সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি, ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	লাইন ডাইরেক্টর (এইচএমএস) ও পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	লাইন ডাইরেক্টর,কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	
১২.	সদস্য সচিব, সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জাতীয় **টেকনিক্যাল** কমিটি	সদস্য
১৩.	------	
১৪.	----------	
১৫.	----------	
১৬.	----------	
১৭.	----------	

১৮.	-------	
১৯.	----------	
২০.	----------	

কার্যপরিধিঃ

১. নীতিমালা, কর্মকৌশল অনুমোদন
২. সি-জে মডেল জাতীয় সম্প্রসারণ কমিটি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশমালা গ্রহণ
৩. অর্থ বরাদ্দ ও অনুমোদন
৪. বছরে ন্যূনতম দু'বার বৈঠকে বসবে
৫. প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে

২. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	উপদেষ্টা
২.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	চেয়ারপারসন
৩.	প্রধান সমন্বয়কারী, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য সচিব
৪.	পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	পরিচালক (প্রশাসন), নার্সিং অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	পরিচালক (অর্থ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৮.	পরিচালক (প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	লাইন ডাইরেক্টর, কমিউনিটি বেজড হেলথ কেয়ার, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	সহকারী পরিচালক (সমন্বয়), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	ফোকাল পারসন, কিউআইএস সেক্রেটারিয়েট, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী, হেলথ সিস্টেমস এন্ড পপুলেশন স্টাডিজ ডিভিশন, আইসিডিডিআর,বি	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, ইউনিসেফ, ঢাকা	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, জাইকা, ঢাকা	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসাসিয়েশন (বিএমএ)	সদস্য
১৭.	ডা. মু. মুশতাক হোসেন, সমন্বয়কারী, সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৮.	ডা. ইমদাদুল হক, সিনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনী), ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল [পিআরএল]	সদস্য
১৯.	মেডিক্যাল অফিসার (৩ জন), সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	সদস্য

কার্যপরিধি

১. দেশের জেলা-উপজেলাতে "চৌগাছা-ঝিনাইদহ জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মডেল" সম্প্রসারণ
২. একদসংক্রান্ত নির্দেশনা, কর্মপরিকল্পনা, এসওপি, ফরম, অ্যাপস, পরিবীক্ষণ ফরম প্রস্তুত করা
৩. এ যাবত মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ সংক্রান্ত সকল কাজের পর্যালোচনা ও সার-সংকলন
৪. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা
৫. প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা
৬. জেলা-উপজেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন
৭. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশে এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা
৮. কমিটি কমপক্ষে মাসে একবার বা প্রয়োজনে একাধিকবার সভায় মিলিত হবে
৯. প্রয়োজনে কমিটিতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে

৩. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জেলা হাসপাতাল কমিউনিটি সহায়তা কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	পৌরসভার মেয়র	চেয়ারপারসন
২.	সিভিল সার্জন	সমন্বয়ক
৩.	তত্ত্বাবধায়ক, জেলা সদর হাসপাতাল	সদস্য সচিব
৪.	সংশ্লিষ্ট আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৫.	জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৬.	ডেপুটি কমিশনারের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৭.	জেলা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৮.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়-এর প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৯.	বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
১০.	জেলা আইনজীবী সমিতির প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
১১.	জেলা প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
১২.	এনজিও'র প্রতিনিধি (ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত - ১ জন)	সদস্য
১৩.	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি (ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক মনোনীত - ১ জন)	সদস্য
১৪.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	সদস্য ও ফোকাল পারসন
১৫.	কনসালটেন্ট (১ জন)	সদস্য

কার্যপরিধিঃ

১. চৌগাছা-ঝিনাইদহ জনসম্পৃক্ত আদর্শ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার আলোকে অত্র হাসপাতাল পরিচালনায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ
২. হাসপাতালের মানসম্মত সেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ করে চিকিৎসার পরিবেশ রক্ষা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান
৩. সরকারী বরাদ্দ ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান
৪. চিকিৎসা সেবার চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি স্থানীয় দাতা ও হিতৈষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট করা, তাদের সহায়তায় একটি কমিউনিটি সাপোর্ট তহবিল গঠন এবং এ বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী তহবিল পরিচালনা
৫. চিকিৎসা সেবার চাহিদা পূরণে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং স্থানীয়ভাবে তা সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ

৬. হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের সেবা প্রদান কাজে উৎসাহ প্রদান এবং দায়িত্ব পালনে গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান
৭. সভাপতির অনুমতিক্রমে সদস্য সংখ্যা প্রয়োজনে বৃদ্ধি বা হ্রাস করা যাবে
৮. কমিটি কাজের সুবিধার জন্য প্রয়োজনে উপ-কমিটি গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে

৪. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা জেলা সদর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধির পদবী	কমিটিতে পদ
১.	তত্ত্বাবধায়ক, জেলা সদর হাসপাতাল	চেয়ারপারসন
২.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	সদস্য সচিব
৩.	বিভিন্ন ডাব্লুআইটি'র ফ্যাসিলিটেটর ও টিম লিডারগণ	সদস্য

কর্মপরিধি

১. বিভিন্ন ডাব্লুআইটি'র কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা
২. পরবর্তী মাসের কর্মপরিকল্পনা
৩. নির্ধারিত ছকে প্রতি মাসে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেদন প্রেরণ
৪. কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ থেকে কোন্ কোন্ বিষয়ে সহযোগিতা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করে প্রস্তাবনা আকারে কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপে সুপারিশ করা
৫. বিভিন্ন ডাব্লুআইটি'র উপস্থাপিত সমস্যাসমূহের সমাধান পদ্ধতিকে অনুমোদন দেয়া
৬. এ কমিটি প্রতি মাসে একবার সভায় বসবে

৫. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কমিউনিটি সহায়তা কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদ
১.	পৌরসভার মেয়র	চেয়ারপারসন/ সভাপতি*
২.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব
৩.	সংশ্লিষ্ট আসনের মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৪.	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৫.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৬.	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৭.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
৮.	উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা (১ জন)	সদস্য
৯.	স্থানীয় প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধি (১ জন)	সদস্য
১০.	এনজিও'র প্রতিনিধি (ইউএনও মনোনীত – ১ জন)	সদস্য
১১.	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি (ইউএনও মনোনীত – ১ জন)	সদস্য
১২.	কনসালটেন্ট (১ জন)	সদস্য
১৩.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (১ জন)	সদস্য

- **যে সকল উপজেলায় পৌরসভা নেই সেখানে উপজেলা চেয়ারম্যান সভাপতি হবেন।**

দায়িত্ব

১. **সি-জে মডেল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা ও একটি কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়ন করা**

২. **উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনার জন্য বিশেষ করে চিকিৎসার পরিবেশ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান**
৩. **সরকারী সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা#**
৪. **চিকিৎসা সেবার চাহিদা পূরণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী বরাদ্দের পাশাপাশি স্থানীয় দাতা ও হিতৈষী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট করা এবং তাদের সহায়তায় একটি কমিউনিটি সহায়তা তহবিল গঠন ও প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচালনা করা।**
৫. **চিকিৎসা সেবার চাহিদা পূরণে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং স্থানীয়ভাবে তা সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।**
৬. **হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য সেবাদানকারীকে উৎসাহিত করা এবং গঠনমূলক পরামর্শ দেয়া**
৭. **প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন ও উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন**
৮. **প্রতি মাসে এ কমিটি অন্ততঃ একটি সভা করবেন**

৬. সি-জে মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বাস্তবায়ন কমিটি

ক্রমিক	কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধির পদবী	কমিটিতে পদ
১.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	চেয়ারপারসন
২.	আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার	সদস্য সচিব ও ফোকাল পারসন
৩.	ডাব্লুআইটি কমিটিসমূহের টিম লিডার ও ফ্যাসিলিটেটরগণ	সদস্য

দায়িত্ব

১. প্রতিটি ডাব্লুআইটি কার্যক্রমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে
২. পরবর্তী মাসের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবে
৩. ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন
৪. কমিউনিটি হতে কোন্ ধরণের সহযোগিতা নেবে তার সুপারিশ তৈরী করে কমিউনিটি সহায়তা কমিটিকে অনুরোধ রূপে পাঠাবে
৫. ডাব্লুআইটি তাদের সমস্যাসমূহ সমাধানে যে সব প্রস্তাব তৈরী করবে তা অনুমোদন করবে
৬. প্রতি মাসে একবার সভা অনুষ্ঠান করবে

জাতীয় কর্মকৌশল বাস্তবায়ন সূচী

নং	কর্ম	বাস্তবায়নকারী	সময়কাল	মন্তব্য
১.	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি গঠন	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	-	সম্পন্ন
২.	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	ডিসেম্বর '১৮	-
৩.	হাতে-কলমে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষজ্ঞ দল গঠন	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	ডিসেম্বর '১৮	-
৪.	দেশব্যাপী প্রাথমিক জরীপ	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র	-	সম্পন্ন

নং	কর্ম	বাস্তবায়নকারী	সময়কাল	মন্তব্য
৫.	সি-জে মডেল বাস্তবায়িত প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	-	সম্পন্ন
৬.	কর্মকৌশল প্রস্তুত করা	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র	-	চলমান
৭.	কর্মকৌশল চূড়ান্তকরণ	জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি	ডিসেম্বর '১৮	-
৮.	প্রথম পর্যায় জেলা-উপজেলা চিহ্নিতকরণ	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	-	সম্পন্ন
৯.	প্রথম পর্যায়ের জেলা-উপজেলার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	ডিসেম্বর'১৮-জানুয়ারি'১৯	-
১০.	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	ডিসেম্বর'১৮-জানুয়ারি'১৯	-
১১.	সকল পক্ষের অংশগ্রহণে মাঠ পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি, বিষয়ভিত্তিক পরিচালক সিবিএইচসি	জানুয়ারী'১৯	-
১২.	প্রথম পর্যায়ের জেলা-উপজেলাতে বাস্তবায়ন শুরু	স্বাস্থ্য অধিপ্তরের সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, বিষয়ভিত্তিক পরিচালক সিবিএইচসি	ফেব্রুয়ারি'১৯	-
১৩.	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ গঠন	সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন/তত্ত্বাবধায়ক জেলা হাসপাতাল	জানুয়ারি'১৯	-
১৪.	দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয় ও সহায়তা কেন্দ্র, বিষয়ভিত্তিক পরিচালক সিবিএইচসি	মার্চ ২০১৯	-
১৫.	সি-জে মডেলের টেকসই উন্নয়ন বজায় রাখা	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি ও কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ	-	চলমান

প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়নসূচী

নং	**কর্মসূচি**	**বাস্তবায়নকারী**	**সময়সীমা**
১.	কমিউনিটি সহায়তা কমিটি গঠন	স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	১৫ দিন
২.	প্রাথমিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি দল	৩০ দিন
৩.	সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ	কিউআইসি ও ডাব্লুআইটি দল	৩০ দিন
৪.	দূরদৃষ্টি, লক্ষ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ	কিউআইসি দল	১৫ দিন
৫.	লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠী ও সেবাদানকারীদের অঙ্গিকার অর্জনে কর্মশালার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ	স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	৯০ দিন
৬.	প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত ও সংগ্রহ	স্থানীয় হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ	১৮০ দিন
৭.	মূল্যবোধভিত্তিক কর্মপরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার নীতিমালা প্রস্তুত করা	কিউআইসি দল	১৫ দিন

৮.	লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল অংশীজনের সাথে মতবিনিময়	কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	৬০ দিন
৯.	মানসম্পন্ন সেবাদানে ৫এস কাইজেন পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	৭ দিন
১০.	প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী দল কর্তৃক চৌগাছা ও ঝিনাইদহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান অর্জন	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	---------
১১.	মডেল সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মডেল হাতে কলমে বাস্তবায়নের জন্য সফর	জাতীয় টেকনিক্যাল কমিটি	৭ দিন
১২.	কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন	স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ	প্রতি ৯০ দিন অন্তর

উপসংহার

স্বাস্থ্যসেবা একটি বহুমাত্রিক মানবিক ব্যবস্থা। মানুষের রোগ প্রতিরোধ, নিরাময়, স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও পুনর্বাসন একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। সরকারের একার পক্ষে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তাই জনসম্পৃক্ততা অপরিহার্য। চৌগাছা-ঝিনাইদহ মডেল জনসম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এ ব্যবস্থাপনা চালুর মাধ্যমে সে সব স্থানে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যবস্থায় জনগণ স্বাস্থ্যসেবা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ পেয়েছে। জনসম্পৃক্ততার ফলে ভবিষ্যতে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে স্বাস্থ্য সেবায় সমস্যাসমমূহ চিহ্নিত করা ও সমাধানে ভূমিকা রাখা সহজ হবে। বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষিত “সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা” কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ মডেল অনেকখানি ভূমিকা রাখবে।

সংযুক্তি

সারনী ১. চৌগাছা মডেল বিকাশের মাইলফলক

১৯৮৫	উপজেলা পরিষদের সহায়তায় নিকটস্থ পাবলিক লাইব্রেরিতে ৬ শয্যার অন্তঃবিভাগ চালু
১৯৮৯	ইপিআই কর্যক্রমে সফলতার জন্য জাতীয় পুরস্কার লাভ
১৯৯৪	নতুন ভবনে ৩১ শয্যার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থানান্তর
১৯৯৫	ওআরটি কর্নার চালু, এবং জাইকার সহযোগিতায় ফ্রন্টলাইন এমসিএইচ কার্যক্রম শুরু
১৯৯৬	এএনসি কর্নার, ও আন্ডার ফাইভ কর্নার চালু
১৯৯৮	জানুয়ারি মাসে বেসলাইন সার্ভে পরিচালনা ও বার্ষিক রিপোর্ট-১৯৯৭ তৈরি করা
২০০০	ইউনিসেফের সহযোগিতায় কম্প্রিহেনসিভ জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম চালু করা
২০০১	২০১০ সাল নাগাদ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ
২০০৪-২০১১	প্রসূতি সেবায় জাতীয় পুরস্কার লাভ
২০০৬	ইউনিসেফের সহযোগিতায় নিরাপদ রক্ত-পরিসঞ্চালন ইউনিট চালু
২০০৭	দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার কার্যক্রম চালু
২০০৮	নারী বান্ধব হাসপাতাল হিসাবে স্বীকৃতি লাভ
২০০৮ জুন	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ ও ৫০ শয্যায় উন্নীত
২০০৯	এমডিজি ৫ ও ৬ অর্জন
২০১০	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক মারগারেট চ্যান এর চৌগাছা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন ও সারা দেশে সম্প্রসারণের সুপারিশ
১ জানু ২০১১	২০১০ সালের লক্ষ্য মাত্রার সফল অর্জন ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু
২০১১ জুলাই	সার্বিক মান উন্নয়নে ৫এস কাইজেন কার্যক্রম শুরু, সহায়তায় জাইকা
২০১৭	প্রথম স্থান অধিকার করে স্বাস্থ্য মন্ত্রী পুরস্কার লাভ ও প্রসূতি সেবায় পুরস্কার লাভ
২০১৮	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১০০ শয্যা হাসপাতাল তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ

তথ্য সূত্র: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চৌগাছা, যশোর

সারনী ২. ঝিনাইদহ মডেলের কার্যক্রমের মাইলফলক

২০১২	মডেলের কর্যক্রম শুরু
২০১৩	কাইজেন রোল মডেল অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার লাভ
২০১৪	ঝিনাইদহ টিমের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল পরিদর্শন, মান সম্পন্ন জেলা হাসপাতাল ২য় পুরস্কার লাভ
২০১৫	মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা পর্যায়ের মডেলের পাইলটিং শুরু ও শ্রেষ্ঠ মান সম্পন্ন জেলা হাসপাতাল পুরস্কার লাভ
২০১৬	১০ টি জেলা হাসপাতালে কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য মন্ত্রী পুরস্কার ও প্রসূতি সেবায় পুরস্কার লাভ
২০১৭	স্বাস্থ্য মন্ত্রী পুরস্কার ও প্রসূতি সেবায় পুরস্কার লাভ

তথ্য সূত্র: তত্ত্বাবধায়কের কার্যালয়, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ

সারনী ৩. চৌগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কার্যক্রমের অগ্রগতি (১৯৯৫-২০১৭)

সূচক	হার সংখ্যা	সাল							
		১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	২০০০	২০০৩	২০০৭	২০১১	২০১৭
শয্যা ব্যবহারের হার	%	-	-	৭৮.৯	৯৩.৫	৮৮.৯	২০১.০	২০৮.০	১৭১.০
গর্ভকালীন পরিচর্যা (১ম বার)	%	-	১৬.৩	২৪.৬	৫৯	৮৮	১৩২	১৭০	১৩০
	সংখ্যা		৮১৭	১২২৮	২৮৬১	৪৪৮৪	৭২৯২	৮৯৩৫	৬৬৩২
হাসপাতালে প্রসব	%	-	২.১	৩.৪	৬.৪	১৫	৩৮.১	৯৮.৪	৬৬
	সংখ্যা		৯৯	১৫১	৪২২	৬৬১	১৮৯৯	৪৪১৩	২৯৩২
সিজারিয়ান সেকশন	%	-	০.০২	০	০.১	০.৮	৯.৬	২২.৫	১৭
	সংখ্যা		১		৩	৩৬	৪৭৩	১০০৭	৭৫৯
জনসংখ্যা বৃদ্ধি	%	১.৮৭	১.৮৬	১.৬৬	১.৭	১.৫৭	-	১.৩৬	১.৭১
মাতৃমৃত্যু (১ লক্ষ)	জীবিত জন্মে	৫৯৯	৩০০	২০৬	১৬৮	১১৪	১৬০	৬৮	৯১
নবজাতক মৃত্যু (১ হাজার)		৪২	৪৭	৪২.৪	২৩	২৮	২১.৫	১৮.২	১৬.৬
শিশু মৃত্যু (১ হাজার)		৬৫	৫৮	৫৬	৩৬	৩৪	২৯.২	২৩.৬	১৮.৬
<৫ ব: শিশু মৃত্যু (১০০০)		৭৮	৬৭	৬২	৪৪	৪৩	৩৩.৩	২৫.৭	২১.১
কম ওজন বিশিষ্ট শিশু	%	-	-	৩৬.৫	১৫.২	১৩.৭	-	-	-
	সংখ্যা			৭৪	২৮৮	৬৩৬			

তথ্যসূত্র: উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা, চৌগাছা, যশোর

সারনী ৪. ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল কার্যক্রমের অগ্রগতি (১৯৯৮-২০১৭)

ক্রমিক	বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা/ হার	সাল				
			১৯৯৮	২০১১	২০১২	২০১৫	২০১৭
১	রোগী: বহিঃবিভাগ ও জরুরী বিভাগ	সংখ্যা	৮১,৭৯৫	১৭০,৮৫৪	১৭১,০৭০	২৭৭,৩০১	৩৪০,৯৩২
২	রোগী: অন্ত:বিভাগ		১২,৯৭৩	২২,৪৩৫	২২,৯৫১	২৯,৫৬২	৩৫,৫৬৯
৩	শয্যায় অবস্থান	%	১২৬	১৪৬	১৪৩	১৯৩	২৪২
৪	গর্ভকালীন পরিচর্যা	সংখ্যা	২৫৬	১,৩৫৪	২,২৬৮	১৩,২৫১	১৫,৩৬০
৫	হাসপাতালে প্রসব		১,১০৬	২,৩৭৫	২,৩৭৯	৩,০৩৪	২,৯৯৭
৬	বড় অপারেশন		-	৭৮০	৯৭৭	১,৫৮২	১,৫৭৮
৭	রাজস্ব আয়	টাকা	-	-	-	৬০,৪৪,৭১৫	৭০,৫৯,৫৬০

তথ্যসূত্র: তত্ত্বাবধায়ক, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ

সারনী ৫. খুলনা বিভাগের প্রসব সেবার ২০১১ ও ২০১৭ সালের তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	হাসপাতাল	প্রসব সেবার ধরন					
		স্বাভাবিক		সিজার অপারেশন		মোট	
	সাল	২০১১	২০১৭	২০১১	২০১৭	২০১১	২০১৭
১	চৌগাছা উপজেলা	৩৪০৬	২১৬৩	১০০৭	৭৫৯	৪৪১৩ (১ম)	২৯২২ (৩য়)
২	খুলনা মেডিকেল কলেজ	১৬৫৭	১৪৪৮	১৩৫৬	১৩৬৫	৩০১৩ (২য়)	২৫২৪
৩	যশোর জেনারেল	১৩৫৪	১১৭২	১৪৯৮	১৭৭৮	২৮৫২(৩য়)	২৯৫০ (২য়)
৪	কুষ্টিয়া জেনারেল	১৭৬২	১৫৯৫	৯১৫	৯১৯	২৬৭৭	২৫১৪
৫	ঝিনাইদহ সদর	১৯৪৭	১৮৫৪	৪৩০	১১৪৩	২৩৩৭	২৯৯৭ (১ম)

তথ্যসূত্র: এম.আই.এস. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সারণি ৬. বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য খাতে সম্পদ বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	দেশ	বছরে স্বাস্থ্য খাতে মাথা পিছু সরকারী ব্যয় (ডলার)	প্রতি ১০০০০ জনসংখ্যায় চিকিৎসকের সংখ্যা	প্রতি ১০০০০ জনসংখ্যায় নার্সের সংখ্যা	প্রতি ১০০০০ জনসংখ্যায় রোগীদের শয্যা সংখ্যা	চিকিৎসা নিতে রোগীদের নিজ খরচ (%)
১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৯৫৩৬	২৫.৫	৯৯	৩৭	১১.০৮
২	যুক্তরাজ্য	৪৩৫৬	২৮.০	৮৪	৩০	১৪.৭৯
৩	মালয়সিয়া	৩৮৬	১২.৮	৩৪	১৮	৩৬.৬৭
৪	শ্রি লংকা	১১৮	৭.৩	১৭.৫	৩১	৩৮.৪৩
৫	ভারত	৬৩	৭.৩	২০.৪	০৯	৬৫.০৬
৬	নেপাল	৪৪	০৮	৪.৭	-	৬০.৪১
৭	পাকিস্তান	৩৮	০৮	০৬	০৬	৬৬.৪০
৮	বাংলাদেশ	৩৭	-	-	-	৬৭.০০

সূত্রঃ বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইট ২০-১০-১৮ তারিখে প্রদর্শিত

সারণি ৭. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	সূচক (প্রভাব/ ফলাফল)	সূচনা বছরের তথ্য (সূচনা বর্ষ)	৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ২০২২ নাগাদ	এসডিজি ২০৩০ নাগাদ
১	প্রত্যাশিত গড় আয়ু (বছরে)	৭০.৪ (এসভিআরএস ২০১৩)	৭২	
২	পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৪৬ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৩৭	২৫
৩	শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৩৮ (বিডিএইচএস ২০১৪)	২০	
৪	মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)	১৭০(এমএমইআইজি ২০১৩)	১০৫	৭০
৫	পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম ওজনের শিশুদের অনুপাত (%)	৩২.৬ (বিডিএইচএস ২০১৪)	২০	
৬	পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে কম উচ্চতার শিশুদের অনুপাত (%)	৩৬.১ (বিডিএইচএস ২০১৪)	২৫	
৭	মোট উর্বরতার হার (প্রতি নারীর মাথা পিছু শিশু)	২.৩ (বিডিএইচএস ২০১৪)	২.০	
৮	জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার (%)	৬২.৪ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৭৫	
৯	এক বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের সবগুলো টিকা নেয়ার হার (%)	৭৮ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৯৫	
১০	চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা প্রসবকৃত শিশু জন্মের অনুপাত (%)	৪২.১ (বিডিএইচএস ২০১৪)	৬৫	
১১	সম্পদের পঞ্চস্তর অনুযায়ী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জন্ম নেয়ার হার (উচ্চতম ও নিম্নতম পঞ্চমাংশের অনুপাত)	১৫:৬৯.৫ (বিডিএইচএস ২০১৪)	১:৩:৫	
১২	যক্ষ্মা সনাক্তের হার (%)	৫৩ (জিটিআর ২০১৪)	৭৫	
১৩	নবজাতকের মৃত্যু হার	২৫ (২০১৪)	১৮	১২
১৪	পাঁচ বছরের সমবয়সী শিশুদের কৃশতার হার	১৪	১২	
১৫	প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্যসেবা (এএনসি) ৪র্থ সাক্ষাৎ	৩১.২	৫০	
১৬	শিশুকে কেবলমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানো	৫৫.৩ (২০১৪)		
১৭	কিশোরীদের উর্বরতার হার (১৫-১৯)	৩১	২৫	
১৮	প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যায় এনসিডিতে মৃত্যুহার (৩০-৬৯ বছর)			

১৮.ক	হৃদরোগ			
১৮.খ	ক্যান্সার			
১৮.গ	ডায়াবেটিস			
১৮.ঘ	দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট			
১৯	সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার (প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায়)	৮৫.৬ (বিশ্ব ব্যাংক ২০০২)		
১৯.ক	পুরুষ			
১৯.খ	নারী			
২০	ধূমপায়ীর হার (প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায়) ১৫+ বছর	-		

সূত্রঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সারণি ৮. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এসডিজি লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা (১৩), ও নির্দেশক (২৭)

নং	লক্ষ্য মাত্রা	নির্দেশক	সূচক (প্রভাব/ফলাফল)	সূচনা বছরের তথ্য (সূচনা বর্ষ)	২০৩০ সাল নাগাদ
১	৩.১	৩.১.১	মাতৃমৃত্যুর হার (প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে)	১৭৬ (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৬)	৭০
২		৩.১.২	চিকিৎসক ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা প্রসবকৃত শিশু জন্মের অনুপাত (%)	৪২.১ (বিডিএইচএস ২০১৪)	
৩	৩.২	৩.২.১	পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)	৪৬ (বিডিএইচএস)	২৫
৪		৩.২.২	নবজাতকের মৃত্যু হার	২৫ (২০১৪)	১২
৫	৩.৩	৩.৩.১	এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার	০.০১%	
৬		৩.৩.২	যক্ষ্মা সনাক্তকরণের হার	৫৩% (২০১৪)	১০০%
৭		৩.৩.৩	ম্যালেরিয়া সংক্রমণের হার (হাই এন্ডেমিক ৩ জেলা)	১-১০/ ১০০০০ জনসংখ্যা (২০১৫)	জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে না থাকা
৮		৩.৩.৪	হেপাটাইটিস বি সংক্রমণের হার		
৯	৩.৪	৩.৪.১	প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যায় এনসিডিতে মৃত্যুহার (৩০-৬৯ বছর)	১৮% (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪)	৬%
		১	হৃদরোগ		
		২	ক্যান্সার		
		৩	ডায়াবেটিস		
		৪	দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসকষ্ট		

নং	লক্ষ্য মাত্রা	নির্দেশক	সূচক (প্রভাব/ফলাফল)	সূচনা বছরের তথ্য (সূচনা বর্ষ)	২০৩০ সাল নাগাদ
১০		৩.৪.২	আত্মহত্যা (প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায়)	৮ (২০১৪)	২.৬৭
			পুরুষ		
			নারী		
১১	৩.৫	৩.৫.১	মাদকাসক্ত রোগীর সংখ্যা (প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যায়)		
১২	৩.৬	৩.৬.১	সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার (প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায়)	৮৫.৬ (বিশ্ব ব্যাংক ২০০২)	অর্ধেক (২০২০)
			পুরুষ		
			নারী		
১৩	৩.৭	৩.৭.১	জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার (%)	৬২.৪ (বিডিএইচএস ২০১৪)	
১৪		৩.৭.২	কিশোরীদের উর্বরতার হার (১৫-১৯ ব.) (ঐ বয়সে প্রতি হাজারে)	৩১	
১৫	৩.৮	৩.৮.২	সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা (প্রতি ১০০০ জনসংখায়)		
১৬	৩.৯	৩.৯.১	পানি, বায়ু ও মাটি দূষণে মৃত্যুর হার কমানো (প্রতি ১০০০ জনসংখায়)		
১৭	৩.a		ধূমপায়ীর হার (প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায়) ১৫+ বছর	২৫% (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪)	
			পুরুষ	৪৮%	
			নারী	০২%	
১৮	৩.b	৩.b.১	সবার জন্য সহজলভ্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ প্রাপ্তি	৬৬% (এইচএফএস ২০১৪)	১০০%
		৩.b.২	সবার জন্য সহজলভ্য ভ্যাক্সিন প্রাপ্তি		
		৩.b.৩	পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সরবরাহ	৮৪.৪% (এইচএফএস ২০১৪)	
১৯	৩.c	৩.c.	স্বাস্থ্য জনশক্তি (প্রতি ১ লক্ষ জনসংখ্যায়)		
		১	মেডিক্যাল অফিসার		
		২	কনসালটেন্ট (ক্লিনিক্যাল)		
		৩	কনসালটেন্ট (প্রতিরোধ)		
		৪	নার্স		
		৫	মিড ওয়াইফ		
		৬	জনস্বাস্থ্য নার্স		

নং	লক্ষ্য মাত্রা	নির্দেশক	সূচক (প্রভাব/ফলাফল)	সূচনা বছরের তথ্য (সূচনা বর্ষ)	২০৩০ সাল নাগাদ
		৭	স্যানিটারি ইন্সপেক্টর		
২০	৩.d	৩.d	দুর্যগজনিত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর সক্ষমতা অর্জন		
		৩.d.১	পূর্বসতর্কতা অর্জনের সক্ষমতা		
		৩.d.২	ঝুঁকি কমানোর সক্ষমতা অর্জন		
		৩.d.৩	ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের সক্ষমতা অর্জন		

সূত্রঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

-সমাপ্ত-